PROTOCOLLO 74

Retrazione cervicale e allungamento assiale

Correggere la postura con capo in avanti

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	8 a 10 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Postura anteriorizzata del capo
- ✓ Dolore cervicale
- ✓ Tensione dei masticatori

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: seduto, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di lato al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Posizione

Seduto con schiena appoggiata.



Retrazione

Scivola il mento indietro mantenendo lo sguardo orizzontale.



Allungamento

Immagina di crescere verso l'alto.



Mantenimento

Mantieni 5 secondi e rilascia.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	10
Mantenimento	5 secondi
Frequenza	3 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)

____ / 10

a riposo e in movimento

MOBILITÀ

____°

rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI

Migliorati / Invariati

dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Movimento piccolo e preciso
- ✓ Mandibola rilassata
- ✓ Collega a momenti della giornata

Errori da evitare

- ! Flettere il capo in basso
- ! Contrarre le spalle
- ! Movimenti bruschi

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Retrazione del mento	Mento indietro con sguardo orizzontale	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** La postura del capo influenza la posizione mandibolare e il carico muscolare.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.